MODUL PELATIHAN

Modul Peserta
Pelatihan Keberlanjutan CBC

Pelatihan Strategi Keberlanjutan Operasional dan Finansial bagi Pengelola Community-Based Clinic (CBC)

Buku kerja peserta



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Yayasan Spiritia

Draf versi 0.3 · November 2026

Daftar Isi

Selamat Datang....3
Pelajaran 1 Kebijakan, Regulasi, dan Lanskap Pembiayaan HIV....4
Pelajaran 2 Konsep CBC, Prinsip Leave No One Behind, dan Keterlibatan Komunitas....8
Pelajaran 3 Menilai Kesiapan, Tipologi, dan Fondasi Organisasi Klinik....11
Pelajaran 4 Menghitung Biaya dan Memetakan Pendapatan....15
Pelajaran 5 Opsi Pembiayaan, Kredensialing JKN, dan Kontrak Pemerintah....19
Pelajaran 6 Proyeksi Arus Kas dan Skenario....23
Pelajaran 7 Menjaga Akses, Kerahasiaan, dan Peran Komunitas....26
Pelajaran 8 Menyusun Rencana Transisi Klinik....29
Rencana Tindak Lanjut Saya....33
Kunci Jawaban Uji Pemahaman....34
Daftar Istilah....35
Daftar Pustaka....36

Selamat Datang

Buku ini adalah buku kerja Anda selama pelatihan. Isinya sengaja dibuat ringkas: setiap pelajaran memuat inti materi, lembar kerja yang diisi dengan data klinik Anda sendiri, catatan, dan uji pemahaman. Uraian lengkap ada di Pedoman Model CBC Berkelanjutan [1], dan bagian "Baca lebih lanjut" menunjukkan babnya.

Pelatihan ini membantu Anda menyiapkan klinik agar tetap melayani ODHIV, populasi kunci, dan komunitas terdampak ketika dukungan donor berkurang. Pada akhir pelatihan, Anda pulang membawa rancangan rencana transisi klinik yang disusun dari lembar-lembar kerja di buku ini.

Setiap pelajaran berisi

Inti materi	Pokok-pokok yang perlu Anda pahami, dengan gambar dan contoh.
✎ **Lembar kerja**	Diisi dengan data klinik Anda. Hasilnya dipakai lagi di pelajaran berikutnya.
Catatan saya	Ruang menulis gagasan, pertanyaan, dan hal yang ingin dibawa pulang.
? Uji pemahaman	Lima soal pilihan ganda. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.
E-LEARNING	Alat interaktif padanan lembar kerja: perhitungan dilakukan otomatis dan hasilnya tersimpan.

Peta pelajaran

	Mata pelatihan	Topik	Waktu	Di e-learning
1	MPD 1	Kebijakan dan pembiayaan HIV	2 JPL	Unit 0
2	MPD 2	CBC dan komunitas	3 JPL*	Unit 1
3	MPI 1	Kesiapan dan tipe klinik	3 JPL	Unit 2
4	MPI 2	Biaya dan pendapatan	4 JPL	Unit 3
5	MPI 3	JKN dan kontrak pemerintah	5 JPL	Unit 4
6	MPI 4	Arus kas dan skenario	4 JPL	Unit 5
7	MPI 5	Akses dan kerahasiaan	2 JPL	Unit 6
8	MPI 6	Rencana transisi	3 JPL	Unit 7

* Termasuk 1 JPL penugasan mandiri di e-learning sebelum kelas. 1 JPL = 45 menit.

> **Ingat**
>
> **Siapkan sebelum datang:** hasil self-assessment klinik Anda, data biaya dan pendapatan tiga bulan terakhir, jumlah kunjungan per jenis layanan, serta daftar staf dan sumber honornya. Lembar kerja di buku ini akan jauh lebih berguna bila diisi dengan angka nyata.

PELAJARAN 1

Kebijakan, Regulasi, dan Lanskap Pembiayaan HIV

MPD 1 · 2 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- menjelaskan situasi epidemi HIV dan target nasional
- menyebutkan regulasi yang mengatur CBC
- menjelaskan perubahan pendanaan dan arah transisi

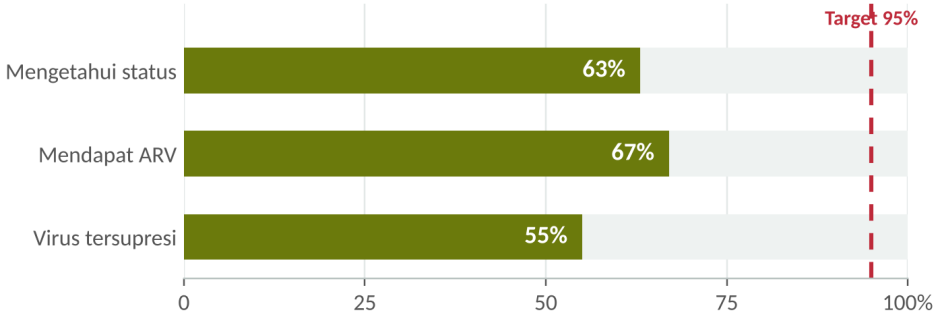
Produk kerja
Peta fungsi klinik dan siapa yang membiayainya

Di e-learning
Unit 0 · Orientasi dan kuis kebijakan

INTI MATERI

1.1 Situasi epidemi dan target nasional

Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 564.000 orang dengan HIV pada 2025 [2]. Capaian tiga indikator 95-95-95 masih jauh dari target: 63% mengetahui status, 67% mendapat ARV, dan 55% virusnya tersupresi. Pemerintah menargetkan eliminasi HIV, AIDS, dan IMS pada 2030 [3].



Gambar 1.1 Capaian 95-95-95 Indonesia, 2025

Kesenjangan terbesar ada di awal kaskade: menemukan orang yang belum mengetahui statusnya dan menjaga mereka tetap berobat. Di dua titik inilah CBC paling berperan, karena komunitas lebih mudah dijangkau oleh layanan yang mereka percaya.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 1.1

1.2 Regulasi yang perlu Anda kenal

Anda tidak perlu menghafal nomor peraturan. Yang penting, Anda tahu regulasi mana yang membuka jalan bagi langkah klinik Anda.

Urusan	Regulasi pokok	Artinya bagi klinik
Izin klinik	PP 28/2025; Permenkes 11/2025	Izin diurus lewat OSS; akreditasi paling lambat dua tahun setelah izin terbit [4,5]
JKN	Perpres 82/2018 dan perubahannya; Permenkes 71/2013; Permenkes 3/2023	Klinik pratama dapat menjadi FKTP dan menerima kapitasi [6–8]
Kontrak daerah	Perpres 46/2025; Peraturan LKPP 3/2021	Pemda dapat membeli layanan komunitas lewat swakelola tipe III [9,10]
HIV dan SPM	Permenkes 23/2022; Permenkes 6/2024	Peran masyarakat diakui; layanan SPM bagi orang berisiko HIV boleh diberikan fasilitas swasta [11]

Urusan	Regulasi pokok	Artinya bagi klinik
Data	UU 27/2022; Permenkes 24/2022	Data kesehatan wajib dilindungi secara khusus; rekam medis elektronik [12,13]

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 1.5 dan Bab 3.4

1.3 Pendanaan berubah, transisi sudah dimulai

Dukungan Global Fund untuk HIV di Indonesia berada pada alokasi terakhir (Grant Cycle 9, 2029–2031) dan dijadwalkan berakhir setelah 2032 [14]. Sejak Maret 2026, Kementerian Kesehatan memimpin proses transisi pembiayaan [15]. Arah global pun sama: layanan HIV masuk ke layanan primer dan jaminan kesehatan, sedangkan layanan komunitas dibiayai lewat kontrak dengan pemerintah [16].



Gambar 1.2 Linimasa transisi pendanaan

> **Ingat**
>
> Enam tahun terdengar panjang. Namun usulan APBD disiapkan sekitar setahun sebelum anggaran berjalan, dan kredensialing JKN butuh berbulan-bulan. Langkah pertama perlu diambil sekarang.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 1.1 dan Bab 9.1

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 1 Fungsi klinik dan siapa yang membiayainya

Daftar fungsi utama klinik Anda. Tulis siapa yang membiayainya sekarang dan apa yang terjadi bila donor berhenti. Baris pertama adalah contoh.

Fungsi klinik	Dibiayai oleh (sekarang)	Jalur lain yang bisa menopang	Bila donor berhenti…
Penjangkauan populasi kunci	*Donor: honor 3 penjangkau*	*Swakelola tipe III; SPM*	*Penemuan kasus turun*

Fungsi klinik	Dibiayai oleh (sekarang)	Jalur lain yang bisa menopang	Bila donor berhenti…

E-LEARNING Unit 0 · Kuis kebijakan dan peta regulasi interaktif

✎ CATATAN SAYA

Regulasi atau perubahan apa yang paling memengaruhi klinik Anda?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Perkiraan jumlah ODHIV di Indonesia pada 2025 adalah sekitar…
   a. 250.000 orang
   b. 564.000 orang
   c. 356.000 orang
   d. 1.000.000 orang

2. Dukungan Global Fund untuk HIV di Indonesia dijadwalkan berakhir…
   a. Setelah Grant Cycle 9 (2032)
   b. Akhir 2026
   c. Setelah Grant Cycle 8 (2029)
   d. Tidak ada rencana berakhir

3. Dalam JKN, klinik pratama berposisi sebagai…
   a. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan
   b. Laboratorium rujukan
   c. Unit pelaksana teknis daerah
   d. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

4. Regulasi yang mengatur swakelola tipe III oleh organisasi kemasyarakatan adalah…
   a. Permenkes 3/2023
   b. UU 27/2022
   c. Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025
   d. Permenkes 24/2022

5. Menurut UU Pelindungan Data Pribadi, data kesehatan termasuk…

a. Data publik
b. Data pribadi yang bersifat spesifik
c. Data pribadi umum
d. Data yang boleh dibagikan tanpa persetujuan

PELAJARAN 2

Konsep CBC, Prinsip Leave No One Behind, dan Keterlibatan Komunitas

MPD 2 · 3 JPL (termasuk 1 JPL e-learning mandiri)

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- menjelaskan pengertian dan model kepemilikan CBC
- menjelaskan posisi CBC dalam sistem kesehatan
- menerapkan standar minimal keterlibatan komunitas

Produk kerja

Penilaian standar keterlibatan komunitas di klinik Anda

Di e-learning

Unit 1 · Penugasan mandiri sebelum kelas: video testimoni, bacaan, kuis, refleksi

INTI MATERI

2.1 Apa itu CBC

Community-Based Clinic (CBC) adalah klinik berizin yang terutama melayani ODHIV, populasi kunci, serta komunitas rentan dan terdampak. CBC memberikan layanan klinis HIV sesuai standar, dipadukan dengan layanan komunitas seperti penjangkauan dan pendampingan sebaya, dan melibatkan komunitas dalam tata kelolanya.

Ada tiga model kepemilikan: **milik komunitas**, **swasta yang bermitra dengan komunitas**, dan **kemitraan dengan pemerintah**. CBC tetap boleh melayani masyarakat umum. Justru hal ini dapat memperkuat keberlanjutannya.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 2.1

2.2 Posisi CBC dalam sistem kesehatan

Satu klinik dapat memainkan beberapa peran sekaligus, dan setiap peran membuka jalur pembiayaan yang berbeda.



Gambar 2.1 Peran CBC dan jalur pembiayaannya

Perhatian

Penjangkauan, pendampingan sebaya, dan pelaporan paling bergantung pada donor dan paling berisiko hilang, padahal fungsi inilah yang membuat CBC berbeda dari klinik lain.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 2.2–2.3

2.3 Prinsip dan keterlibatan komunitas

Tujuh prinsip berlaku untuk setiap keputusan: tidak meninggalkan siapa pun, keterlibatan bermakna komunitas, hak asasi dan nondiskriminasi, kerahasiaan, akses di atas target pendapatan, mutu sesuai standar, serta akuntabilitas. Agar prinsip itu nyata, setiap CBC perlu memenuhi empat standar minimal keterlibatan komunitas:

1. perwakilan komunitas atau ODHIV duduk di forum pengambil keputusan;
2. pendamping sebaya menjadi bagian tetap tim layanan;
3. ada mekanisme umpan balik dan pengaduan yang ditindaklanjuti;
4. keputusan yang memengaruhi akses dibahas bersama komunitas sebelum diberlakukan.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 1.6 dan Bab 2.1

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 2 Standar keterlibatan komunitas di klinik saya

Standar minimal	Status	Bukti di klinik saya	Langkah perbaikan
Wakil komunitas di forum keputusan	☐ Sudah ☐ Sebagian ☐ Belum		
Pendamping sebaya sebagai tim tetap	☐ Sudah ☐ Sebagian ☐ Belum		
Mekanisme umpan balik dan pengaduan	☐ Sudah ☐ Sebagian ☐ Belum		
Keputusan akses dibahas lebih dulu	☐ Sudah ☐ Sebagian ☐ Belum		

E-LEARNING Unit 1 · Tulis refleksi mandiri Anda di e-learning sebelum hari pertama

✎ CATATAN SAYA

Hal apa dari kartu kasus di kelas yang paling mirip dengan klinik Anda?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Manakah yang **bukan** unsur pengertian CBC dalam pedoman?

a. Berizin sebagai fasilitas pelayanan kesehatan
b. Sasaran utamanya ODHIV dan populasi kunci
c. Harus dimiliki pemerintah daerah
d. Melibatkan komunitas secara bermakna

2. Organisasi disebut dipimpin komunitas (community-led) bila…

a. Menerima dana dari donor internasional
b. Sebagian besar tata kelola, kepemimpinan, staf, dan relawannya berasal dari dan bertanggung jawab kepada komunitas yang dilayani
c. Berlokasi di permukiman padat
d. Melayani lebih dari 500 pengguna

3. Contoh standar minimal keterlibatan komunitas adalah…

a. Ada perwakilan komunitas atau ODHIV dalam badan pengawas atau forum keputusan
b. Semua staf harus berasal dari komunitas
c. Komunitas menanggung biaya operasional
d. Klinik hanya melayani komunitas

4. Risiko keberlanjutan yang khas pada CBC Model 2 (swasta bermitra dengan komunitas) adalah…

a. Ketergantungan pada program pemerintah
b. Tidak dapat memperoleh izin klinik
c. Tidak boleh bekerja sama dengan BPJS
d. Misi sosial bergeser ke orientasi pendapatan

5. Klinik ingin menaikkan tarif sehingga sebagian waria berhenti datang, walaupun pendapatan naik. Prinsip yang dilanggar adalah…

a. Mutu sesuai standar
b. Akuntabilitas dan transparansi
c. Akses dijaga di atas target pendapatan
d. Kerahasiaan

PELAJARAN 3

Menilai Kesiapan, Tipologi, dan Fondasi Organisasi Klinik

MPI 1 · 3 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- menghitung skor kesiapan klinik
- menentukan tingkat kesiapan dan tipe klinik
- menetapkan tiga prioritas penguatan organisasi

Produk kerja

Skor kesiapan, tipe klinik, dan tiga prioritas penguatan

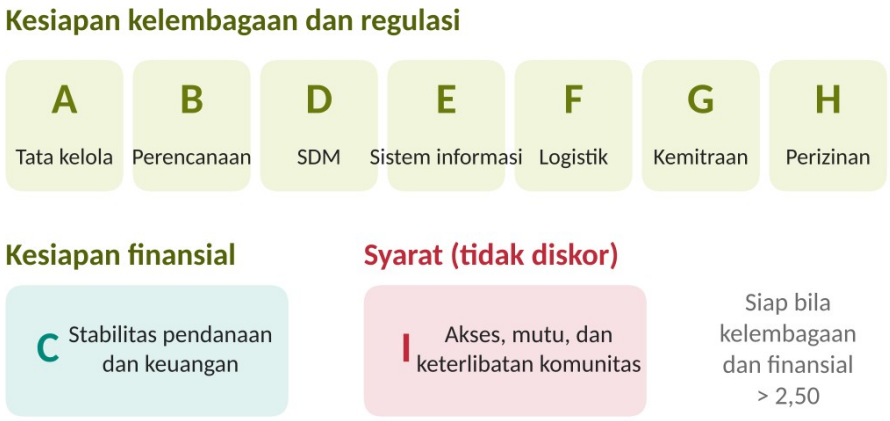
Di e-learning

Unit 2 · Self-assessment interaktif: skor, tingkat, dan tipe dihitung otomatis

INTI MATERI

3.1 Sembilan domain kesiapan

Klinik disebut berkelanjutan bila layanannya tetap bermutu, terjangkau, dan diterima komunitas ketika satu sumber dana berkurang. Kesiapan menuju ke sana dinilai dari sembilan domain dengan skala 1–4.



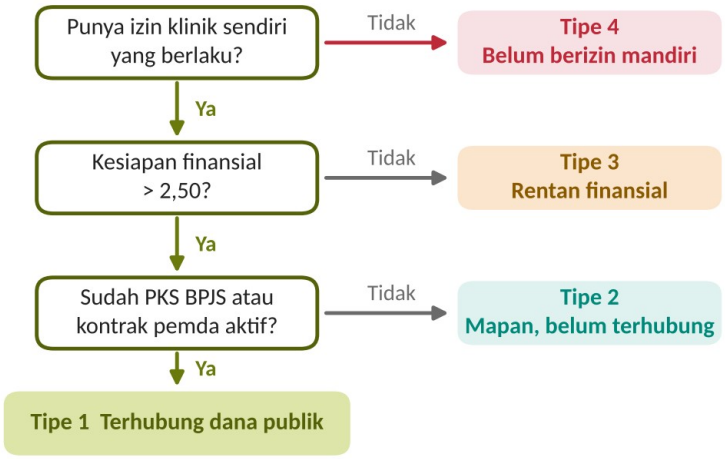
Gambar 3.1 Domain kesiapan kelembagaan, finansial, dan syarat akses

Rata-rata skor domain dibaca sebagai empat tingkat: **merintis** (≤ 1,75), **berkembang** (≤ 2,50), **mapan** (≤ 3,25), dan **maju** (> 3,25). Klinik dianggap siap menghadapi transisi bila kesiapan kelembagaan dan finansial sama-sama di atas 2,50.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 2.4–2.5 dan Lampiran 1

3.2 Menentukan tipe klinik

Tiga pertanyaan sederhana menentukan tipe klinik. Tipe menunjukkan langkah mana yang perlu didahulukan.



Gambar 3.2 Tiga pertanyaan penentu tipe klinik

> **Dari tujuh CBC**
>
> Hasil self-assessment Oktober 2026 [17]: satu klinik Tipe 1, tiga Tipe 2, dua Tipe 3, dan satu Tipe 4. Butir terlemah di hampir semua klinik adalah kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 2.6 dan Lampiran 2

3.3 Fondasi organisasi

Pembiayaan baru hanya bisa masuk bila fondasinya kuat. Empat hal paling menentukan:

1. **Tata kelola:** struktur tertulis, badan pengawas aktif, keputusan tercatat, dan wakil komunitas.
2. **SDM:** peta staf dan sumber honornya. Dalam self-assessment, 11 dari 23 responden masih dibayar dari honor donor.
3. **Sistem:** pelaporan SIHA tepat waktu dan rekam medis elektronik yang tersambung ke SATUSEHAT.
4. **Jenis izin:** klinik pratama adalah FKTP dan dapat menerima kapitasi; klinik utama adalah FKRTL [7].

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 3–4 dan Lampiran 3–6

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 3a Skor kesiapan klinik saya

Domain	Skor (1–4)	Bukti atau catatan
A Tata kelola		
B Perencanaan		
C Stabilitas pendanaan dan keuangan		
D SDM		
E Sistem informasi		
F Logistik		
G Kemitraan		
H Perizinan dan JKN		

Domain	Skor (1–4)	Bukti atau catatan
I Akses, mutu, dan keterlibatan komunitas (syarat)		

Kesiapan kelembagaan (rata-rata A, B, D–H)		**Tingkat kesiapan**	
Kesiapan finansial (domain C)		**Tipe klinik**	

Lembar Kerja 3b Tiga prioritas penguatan

No	Prioritas	Mengapa penting	Siapa	Kapan
1				
2				
3				

E-LEARNING Unit 2 · Masukkan skor di alat self-assessment; tingkat dan tipe keluar otomatis

✎ CATATAN SAYA

Butir mana yang skornya paling berbeda antarpenilai di klinik Anda, dan mengapa?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Skor domain sebuah klinik 2,30. Tingkat kesiapannya adalah…

a. Merintis
b. Mapan
c. Maju
d. Berkembang

2. Klinik memiliki izin klinik pratama, tetapi kesiapan finansialnya 2,10. Tipe kliniknya adalah…

a. Tipe 1
b. Tipe 2
c. Tipe 3
d. Tipe 4

3. Bagaimana domain I (akses, mutu, dan keterlibatan komunitas) diperlakukan?
   a. Dijumlahkan ke kesiapan kelembagaan
   b. Tidak dihitung dalam skor, tetapi menjadi syarat bagi setiap rencana keberlanjutan
   c. Dijumlahkan ke kesiapan finansial
   d. Diabaikan

4. Dua penilai dari klinik yang sama berbeda 2 poin pada satu butir. Langkah yang tepat adalah…
   a. Membahas bukti bersama lalu menyepakati kondisi sebenarnya
   b. Mengambil skor tertinggi
   c. Menghapus butir tersebut
   d. Mengambil skor pimpinan

5. Strategi paling tepat untuk mempertahankan staf kunci yang honornya dibayar donor adalah…
   a. Menunggu donor baru
   b. Memberhentikan staf sebelum donor berakhir
   c. Membebankan honor kepada pengguna
   d. Memindahkan honor secara bertahap ke sumber yang lebih stabil sesuai porsi waktu kerja

PELAJARAN 4

Menghitung Biaya dan Memetakan Pendapatan

MPI 2 · 4 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- membedakan biaya tetap, biaya variabel, dan nilai in-kind
- menghitung biaya per layanan
- menghitung kesenjangan pendanaan dan daya tahan kas

Produk kerja

Lembar biaya per layanan dan matriks siapa membiayai apa

Di e-learning

Unit 3 · Kalkulator biaya per layanan

INTI MATERI

4.1 Mengenali jenis biaya

Biaya tetap tidak berubah walau kunjungan naik-turun, misalnya honor tetap dan sewa. **Biaya variabel** bertambah di setiap kunjungan, misalnya bahan habis pakai. **Nilai in-kind** adalah barang atau jasa yang diterima tanpa membayar, seperti ARV dan reagen program. Biaya tunai ditambah nilai in-kind disebut **biaya penuh**.



Angka fiktif per bulan; in-kind = ARV dan reagen dari program.

Gambar 4.1 Tanpa nilai in-kind, biaya klinik terlihat jauh lebih kecil

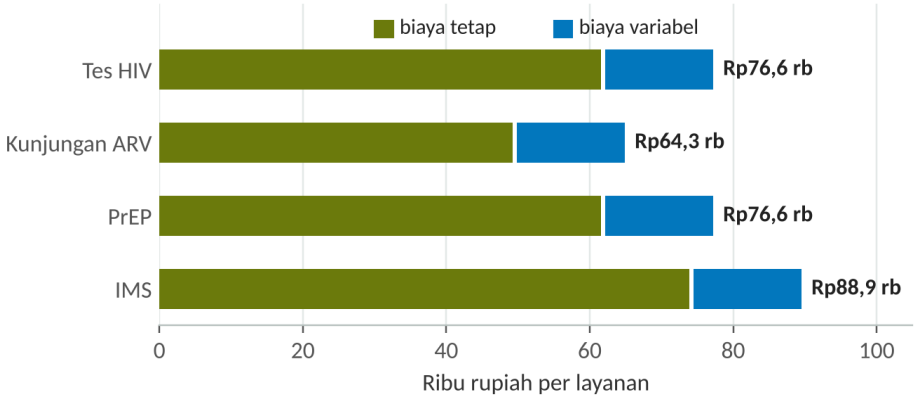
> **Ingat**
>
> Honor staf yang dibayar donor tetap dihitung sebagai biaya tetap, dengan catatan sumber pembayarnya donor. Biaya itulah yang nanti harus dicari penggantinya.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 5.2

4.2 Biaya per layanan

Biaya tetap dibagi ke setiap layanan menurut waktu yang dipakainya. Layanan acuan, misalnya tes HIV 30 menit, diberi bobot 1,0. Layanan yang rata-rata butuh 24 menit berbobot 0,8.

Contoh. Biaya tetap Rp50,5 juta per bulan dibagi 820 unit tertimbang, sehingga biaya tetap per unit Rp61.585. Biaya satu tes HIV menjadi Rp61.585 × 1,0 + biaya variabel Rp15.000 = **Rp76.585**.



Gambar 4.2 Biaya per layanan di klinik contoh

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 5.3 dan Lampiran 7

4.3 Kesenjangan dan daya tahan kas

Kesenjangan adalah biaya tunai bulanan dikurangi pendapatan yang tetap ada setelah donor berhenti. **Daya tahan kas** adalah saldo kas dibagi kesenjangan itu. Klinik contoh punya biaya tunai Rp64 juta dan pendapatan non-donor Rp8 juta, sehingga kesenjangannya Rp56 juta. Dengan saldo kas Rp90 juta, klinik hanya bertahan sekitar 1,6 bulan. Target cadangan yang dianjurkan adalah tiga kali biaya tunai bulanan, atau Rp192 juta.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 5.4–5.6

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 4a Biaya per layanan

Total biaya tetap per bulan		Total unit tertimbang		Biaya tetap per unit	

Layanan	Volume/ bulan	Bobot waktu	Unit tertimbang	Biaya variabel	Biaya per layanan
Tes HIV	*300*	*1,0*	*300*	*Rp15.000*	*Rp76.585*

Lembar Kerja 4b Kesenjangan dan daya tahan kas

1 Biaya tunai per bulan	Rp
2 Pendapatan yang tetap ada setelah donor berhenti	Rp
3 Kesenjangan (1 − 2)	Rp

4 Saldo kas saat ini	Rp
5 Daya tahan kas (4 ÷ 3)	bulan
6 Target cadangan (3 × 1)	Rp

Lembar Kerja 4c Matriks siapa membiayai apa

Beri tanda ✓ pada sumber yang membiayai setiap fungsi. Fungsi yang hanya bertanda di kolom donor adalah fungsi yang paling berisiko.

Fungsi	Donor	JKN	APBD	Program (in-kind)	Pendapatan sendiri
Layanan klinis HIV					
Penjangkauan					
Pendampingan sebaya					
Pelaporan dan data					
Administrasi dan keuangan					

E-LEARNING Unit 3 · Kalkulator menghitung unit tertimbang, biaya per layanan, dan daya tahan kas

✎ CATATAN SAYA

Biaya apa yang selama ini tidak terlihat karena dibayar pihak lain?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. ARV yang diterima klinik dari program pemerintah dalam perhitungan biaya dicatat sebagai…

a. Nilai in-kind
b. Biaya variabel yang dibayar klinik
c. Pendapatan layanan
d. Tidak perlu dicatat

2. Biaya tetap Rp40.000.000 dan total unit tertimbang 800. Layanan dengan bobot 0,8 dan biaya variabel Rp10.000 memiliki biaya per layanan…

a. Rp40.000
b. Rp60.000
c. Rp32.000
d. Rp50.000

3. Biaya tunai Rp60 juta per bulan dan pendapatan non-donor Rp15 juta. Kesenjangan pendanaannya…
   a. Rp15 juta
   b. Rp60 juta
   c. Rp45 juta
   d. Rp75 juta

4. Dengan kesenjangan Rp45 juta per bulan dan saldo kas Rp90 juta, daya tahan kas klinik adalah…
   a. 1 bulan
   b. 2 bulan
   c. 3 bulan
   d. 4,5 bulan

5. Kegunaan utama matriks siapa membiayai apa adalah…
   a. Melihat fungsi yang hilang bila satu sumber berhenti dan mencegah pembiayaan ganda
   b. Menghitung pajak
   c. Menentukan gaji staf
   d. Menghitung jumlah peserta JKN

PELAJARAN 5

Opsi Pembiayaan, Kredensialing JKN, dan Kontrak Pemerintah

MPI 3 · 5 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- menyusun kombinasi pembiayaan yang sesuai
- menyiapkan langkah kredensialing JKN
- menyusun rancangan kerangka acuan kerja (KAK) swakelola

Produk kerja

Matriks sumber dana, daftar periksa kredensialing, dan rancangan KAK

Di e-learning

Unit 4 · Daftar periksa kredensialing BPJS dan swakelola

INTI MATERI

5.1 Membangun kombinasi pembiayaan

Bangun pembiayaan dari bawah: dana publik lebih dulu, lalu komoditas program, sumber pelengkap, dan terakhir cadangan. Dana publik adalah sumber yang paling mungkin bertahan lama.



Gambar 5.1 Urutan membangun kombinasi pembiayaan

Kapitasi JKN dibayar per peserta terdaftar setiap bulan. Untuk klinik pratama besarnya Rp9.000–16.000 per peserta [8]. Klinik dengan 2.500 peserta dan tarif Rp12.000 menerima sekitar Rp30 juta per bulan bila kinerjanya penuh. Komponen yang sudah dibiayai program tidak boleh diklaim lagi ke JKN atau kontrak lain.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 6 dan Lampiran 9–10

5.2 Kredensialing JKN

BPJS Kesehatan menilai calon FKTP dari empat kriteria: SDM, sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Penilaian melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan [18].



Gambar 5.2 Langkah kredensialing sampai perjanjian kerja sama

> **Ingat**
>
> Peserta JKN umumnya baru dapat pindah FKTP setelah tiga bulan terdaftar [19]. Ajak komunitas dan masyarakat sekitar mendaftar ke klinik Anda tanpa memaksa.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 7.1–7.2 dan Lampiran 11

5.3 Kontrak dengan pemerintah daerah

Melalui **swakelola tipe III**, pemerintah daerah membeli layanan dari organisasi kemasyarakatan, misalnya penjangkauan, tes di komunitas, dan pendampingan [9,10]. Berbeda dengan hibah, swakelola adalah pembelian layanan sesuai KAK. Kontraknya ditandatangani pejabat pembuat komitmen dan pimpinan organisasi.



Gambar 5.3 Kapan usulan harus masuk dalam siklus anggaran daerah

Saat beradvokasi, bawa empat hal: **data** layanan, **biaya** yang masuk akal, **dukungan** komunitas, dan **usulan** yang spesifik.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 7.3–7.5 dan Lampiran 12–13

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 5a Pilihan sumber dana

Sumber	Bisa diakses?	Perkiraan per bulan	Waktu sampai cair	Prioritas
Kapitasi JKN	☐ Ya ☐ Belum			
Non-kapitasi JKN	☐ Ya ☐ Belum			
Swakelola tipe III / APBD	☐ Ya ☐ Belum			
Hibah daerah	☐ Ya ☐ Belum			
Komoditas program	☐ Ya ☐ Belum			

Sumber	Bisa diakses?	Perkiraan per bulan	Waktu sampai cair	Prioritas
Pendapatan layanan	☐ Ya ☐ Belum			
CSR, zakat, filantropi	☐ Ya ☐ Belum			

Lembar Kerja 5b Daftar periksa kredensialing

Kriteria	Yang perlu disiapkan	Status	Tindak lanjut
SDM	Dokter penanggung jawab; STR dan SIP lengkap	☐ Siap ☐ Belum	
Sarana dan prasarana	Ruang, alat, jejaring laboratorium dan apotek	☐ Siap ☐ Belum	
Lingkup pelayanan	Layanan primer lengkap, termasuk pasien umum	☐ Siap ☐ Belum	
Komitmen pelayanan	Jam layanan, aplikasi BPJS, rekam medis elektronik	☐ Siap ☐ Belum	

Lembar Kerja 5c Rancangan KAK swakelola

Latar belakang	
Layanan yang ditawarkan	
Sasaran dan target	
Keluaran	
Biaya (dari Lembar Kerja 4a)	
Jangka waktu	
Pelaporan	

E-LEARNING Unit 4 · Daftar periksa interaktif dan contoh KAK yang dapat diunduh

✎ CATATAN SAYA

Apa masukan narasumber BPJS dan Dinas Kesehatan yang paling penting bagi klinik Anda?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Kapitasi JKN dibayarkan berdasarkan…
   a. Jumlah kunjungan per bulan
   b. Jumlah peserta terdaftar per bulan
   c. Jumlah ODHIV yang dilayani
   d. Jumlah tenaga kesehatan

2. Standar tarif kapitasi klinik pratama menurut Permenkes 3/2023 adalah…
   a. Rp9.000–16.000
   b. Rp3.600–9.000
   c. Rp16.000–25.000
   d. Rp3.000–4.000

3. Manakah yang **bukan** kriteria teknis kredensialing BPJS Kesehatan?
   a. Sumber daya manusia
   b. Kelengkapan sarana dan prasarana
   c. Komitmen pelayanan
   d. Jumlah ODHIV yang dilayani klinik

4. Klinik ingin kegiatan penjangkauannya dibiayai APBD tahun 2028. Kapan sebaiknya klinik mulai mengusulkan?
   a. Desember 2027
   b. Januari 2028
   c. Januari–Maret 2027 melalui musrenbang
   d. Setelah APBD 2028 ditetapkan

5. Contoh pembiayaan ganda adalah…
   a. Honor staf dibagi ke dua sumber sesuai porsi waktu kerja
   b. Reagen dari program pemerintah diklaim lagi ke JKN
   c. Klinik menerima kapitasi dan kontrak swakelola untuk kegiatan berbeda
   d. Klinik mencatat nilai in-kind

PELAJARAN 6

Proyeksi Arus Kas dan Skenario

MPI 4 · 4 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- menyusun proyeksi arus kas bulanan
- membandingkan skenario dasar, pesimis, dan optimis
- menghitung titik impas dan kebutuhan dana minimum

Produk kerja
Proyeksi 36 bulan dengan tiga skenario

Di e-learning
Unit 5 · Simulator arus kas dan skenario

INTI MATERI

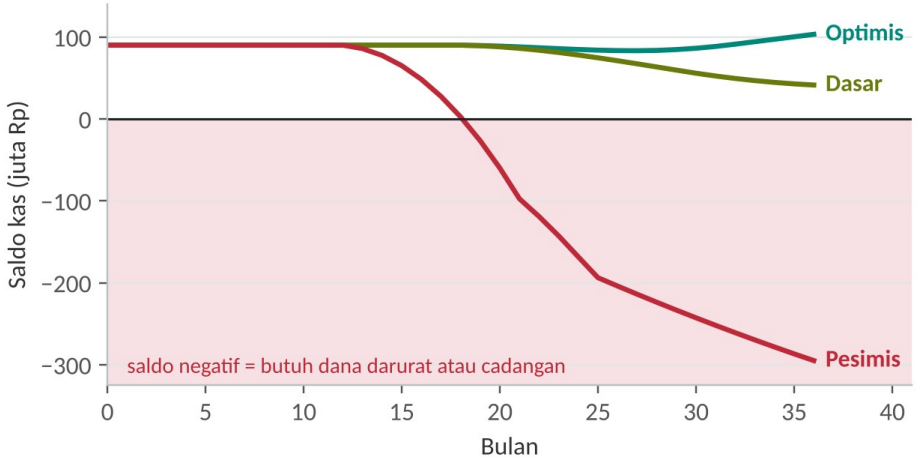
6.1 Proyeksi arus kas bulanan

Proyeksi bulanan memperlihatkan **bulan rawan**, misalnya awal tahun ketika dana daerah belum cair atau saat hibah berakhir. Beri label mutu pada setiap angka: **A** dari dokumen, **B** estimasi pengelola, **C** asumsi atau patokan. Makin banyak angka berlabel C, makin hati-hati Anda membaca hasilnya.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 5.5 dan Lampiran 8

6.2 Tiga skenario

Skenario **dasar** memakai asumsi yang paling mungkin. Skenario **pesimis** dipakai untuk menentukan cadangan darurat. Skenario **optimis** menunjukkan investasi yang dapat dipercepat.



Gambar 6.1 Saldo kas pada tiga skenario (ilustrasi)

6.3 Titik impas dan kebutuhan dana minimum

Bila defisit Rp9 juta per bulan dan tarif kapitasi Rp12.000, klinik membutuhkan sekitar 750 peserta tambahan. Hitung ulang angka ini di Simulator, karena peserta baru yang berkunjung juga menambah biaya variabel.

Kebutuhan dana minimum adalah biaya fungsi yang harus dipertahankan selama peralihan, dihitung dari skenario pesimis. Inilah batas bawah yang perlu diamankan sebelum donor berakhir.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 6.3 dan Bab 9.4

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 6 Ringkasan skenario 36 bulan

Skenario	Asumsi utama	Saldo terendah	Bulan rawan	Tindakan bila terjadi
Dasar				
Pesimis				
Optimis				

Titik impas peserta JKN	peserta
Kebutuhan dana minimum per bulan	Rp
Jumlah angka berlabel C	

E-LEARNING Unit 5 · Simulator menggambar grafik tiga skenario dan menandai bulan rawan

✎ CATATAN SAYA

Asumsi mana yang paling tidak pasti, dan bagaimana Anda akan memastikannya?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Kegunaan utama skenario pesimis adalah…
   a. Menyusun laporan kepada donor
   b. Menghitung gaji staf
   c. Menentukan cadangan dan langkah darurat
   d. Menarik peserta JKN

2. Kebutuhan dana minimum adalah…
   a. Seluruh biaya klinik saat ini
   b. Biaya fungsi berarah pertahankan dan integrasikan selama peralihan
   c. Biaya fungsi yang dihentikan
   d. Nilai kapitasi bulanan

3. Defisit bulanan Rp6 juta dan tarif kapitasi Rp12.000 per peserta. Tambahan peserta yang dibutuhkan sekitar…

a. 500
b. 200
c. 600
d. 1.200

4. Bulan rawan dalam arus kas CBC yang bergantung pada dana daerah biasanya…

a. Akhir tahun anggaran
b. Pertengahan tahun
c. Bulan Ramadan
d. Awal tahun anggaran ketika dana daerah belum cair

5. Angka dengan label mutu B artinya…

a. Berasal dari dokumen atau laporan
b. Asumsi atau patokan
c. Estimasi pengelola
d. Belum diisi

PELAJARAN 7

Menjaga Akses, Kerahasiaan, dan Peran Komunitas

MPI 5 · 2 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- menguji keputusan pembiayaan dengan enam guardrail akses
- mengenali titik risiko kerahasiaan
- menyusun pesan perubahan bagi pengguna

Produk kerja

Hasil uji guardrail dan pesan perubahan untuk pengguna

Di e-learning

Unit 6 · Uji guardrail interaktif

INTI MATERI

7.1 Enam guardrail akses

Setiap sumber dana baru membawa aturan baru. Agar tidak ada pengguna yang tersisih, uji setiap rencana tarif atau perubahan layanan dengan enam guardrail berikut.



Gambar 7.1 Enam guardrail akses

Dari tujuh CBC

Satu CBC menarik biaya administrasi dari semua pengunjung. Pengelolanya mencatat bahwa biaya ini memberatkan pengguna yang kurang mampu.

Tinjau ulang perubahan bila kunjungan populasi kunci turun, angka putus berobat naik, atau pengaduan soal biaya berulang.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 8.1–8.2 dan Lampiran 14

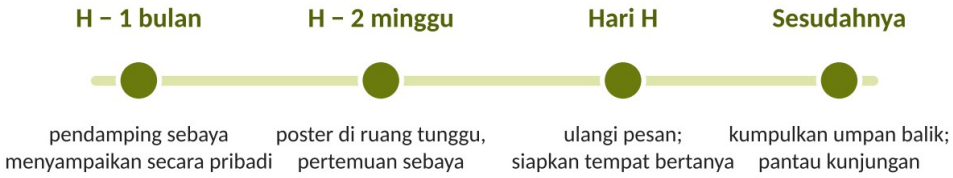
7.2 Kerahasiaan

Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik dan wajib dilindungi secara khusus [12]. Risiko bertambah ketika klinik masuk JKN dan berbagi data dengan pemerintah daerah: saat pendaftaran, klaim, pelaporan, hingga pesan singkat kepada pengguna. Setiap titik itu perlu pengaman, misalnya persetujuan tertulis, akses data terbatas, dan pelaporan agregat.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 8.3

7.3 Peran komunitas dan komunikasi perubahan

Komunitas **memantau** mutu dan akses, **mendampingi** pengguna mendaftar atau pindah FKTP, dan **menyuarakan** kebutuhan dalam musrenbang dan advokasi anggaran. Saat ada perubahan, sampaikan apa yang berubah **dan apa yang tidak berubah**, misalnya ARV tetap tersedia dan data tetap rahasia.



Gambar 7.2 Alur komunikasi perubahan kepada pengguna

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 8.4–8.6 dan Lampiran 15–16

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 7a Uji guardrail

Rencana yang diuji (misalnya tarif baru, pengalihan layanan)	

Guardrail	Terpenuhi?	Catatan atau penyesuaian
1 Layanan inti HIV tanpa biaya bagi yang tidak mampu	☐ Ya ☐ Tidak	
2 Tidak ada penolakan layanan	☐ Ya ☐ Tidak	
3 Keringanan yang tidak mempermalukan	☐ Ya ☐ Tidak	
4 Batas tarif disepakati bersama komunitas	☐ Ya ☐ Tidak	
5 Dampak dipantau setiap bulan	☐ Ya ☐ Tidak	
6 Perubahan dibahas lebih dulu dengan komunitas	☐ Ya ☐ Tidak	

Lembar Kerja 7b Pesan perubahan untuk pengguna

Apa yang berubah	
Apa yang tidak berubah	
Kapan mulai berlaku	
Ke mana bertanya atau mengadu	

E-LEARNING Unit 6 · Uji guardrail dan contoh pesan untuk pendamping sebaya

✎ CATATAN SAYA

Kelompok pengguna mana yang paling mungkin tersisih oleh rencana klinik Anda?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Guardrail pertama menyatakan bahwa…
   a. Semua layanan harus gratis
   b. Tarif ditetapkan oleh pimpinan klinik
   c. Hanya peserta JKN yang dilayani
   d. Layanan inti HIV tidak dibebankan kepada pengguna yang tidak mampu

2. Cara keringanan biaya yang sesuai guardrail adalah…
   a. Pengguna wajib membawa surat keterangan tidak mampu sebelum dilayani
   b. Daftar penerima keringanan diumumkan di ruang tunggu
   c. Penilaian tertutup oleh pendamping sebaya tanpa mewajibkan surat untuk memulai layanan
   d. Keringanan hanya untuk peserta JKN

3. Data yang tepat dilaporkan kepada perangkat daerah dalam kontrak swakelola adalah…
   a. Nama dan alamat pengguna
   b. Data agregat tanpa identitas pengguna
   c. Salinan rekam medis
   d. Foto pengguna

4. Perubahan tarif sebaiknya dikomunikasikan kepada pengguna…
   a. Minimal satu bulan sebelum perubahan berlaku
   b. Pada hari perubahan berlaku
   c. Setelah ada pengaduan
   d. Tidak perlu dikomunikasikan

5. Kapan perubahan tarif harus ditinjau ulang?
   a. Bila pendapatan naik
   b. Setiap lima tahun
   c. Bila donor meminta
   d. Bila kunjungan populasi kunci turun berarti dibandingkan sebelumnya

PELAJARAN 8

Menyusun Rencana Transisi Klinik

MPI 6 · 3 JPL

Setelah pelajaran ini, Anda dapat:

- mengklasifikasi fungsi klinik yang bergantung pada donor
- memilih jalur transformasi
- menyusun rancangan rencana transisi

Produk kerja

Rancangan rencana transisi klinik

Di e-learning

Unit 7 · Penyusun rencana transisi (hasil dapat diunduh)

INTI MATERI

8.1 Empat arah untuk setiap fungsi

Tidak semua fungsi harus dipertahankan dengan cara yang sama. Nilai setiap fungsi yang kini dibiayai donor menurut seberapa kritis fungsinya dan apakah ada pihak lain yang dapat menjalankannya.



Gambar 8.1 Matriks arah fungsi

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 9.2 dan Lampiran 18

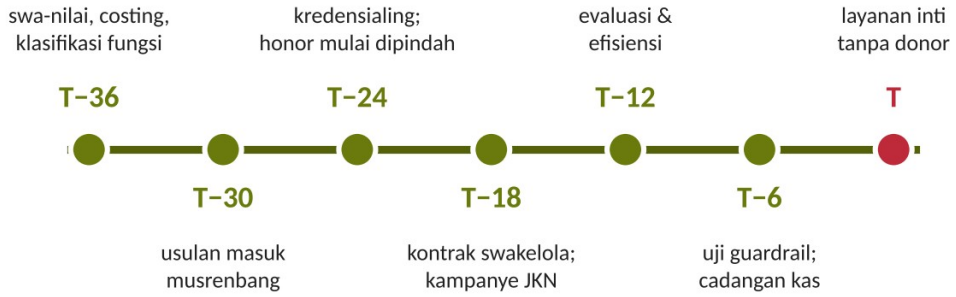
8.2 Enam jalur transformasi

1. **Klinik program menjadi FKTP:** akreditasi, kredensialing, dan menambah peserta.
2. **Klinik utama menjadi pratama:** mengubah atau menambah izin agar dapat menerima kapitasi.
3. **Jejaring menjadi kontrak atau klinik:** swakelola tipe III, atau mendirikan klinik pratama.
4. **Usaha sosial:** layanan berbayar untuk menyubsidi layanan komunitas.
5. **Integrasi dan kontrak:** layanan klinis ke puskesmas, layanan komunitas dikontrak pemda.
6. **Kemitraan atau penggabungan:** berbagi layanan pendukung atau bergabung dengan klinik lain.

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 9.3

8.3 Rencana transisi

Rencana transisi memuat delapan bagian dan disusun mundur dari waktu berakhirnya donor. Rencana disetujui badan pengawas, dibahas dengan komunitas, dipantau setiap bulan, dan direvisi setiap enam bulan.



Gambar 8.2 Linimasa mundur dari berakhirnya donor (T)

Baca lebih lanjut: Pedoman Bab 9.5–9.6, Bab 10, Lampiran 17 dan 19–20

✎ LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 8a Klasifikasi fungsi

Pakai fungsi dari Lembar Kerja 1 dan 4c. Arah: P = pertahankan, I = integrasikan, E = efisienkan, H = hentikan.

Fungsi	Arah	Alasan	Mulai kapan
	P I E H		
	P I E H		
	P I E H		
	P I E H		
	P I E H		

Lembar Kerja 8b Rancangan rencana transisi klinik saya

Bagian	Isi ringkas	Sumber
1 Situasi awal		LK 3
2 Klasifikasi fungsi		LK 8a
3 Jalur transformasi		8.2

Bagian	Isi ringkas	Sumber
4 Target komposisi dana		LK 5a, 6
5 Rencana aksi (siapa, kapan)		LK 3b
6 Akses dan komunikasi		LK 7
7 Risiko dan mitigasi		LK 6
8 Pemantauan		

E-LEARNING Unit 7 · Penyusun rencana transisi mengambil hasil Unit 2–6 secara otomatis

✎ CATATAN SAYA

Masukan sejawat apa yang akan Anda pakai untuk memperbaiki rencana ini?

? UJI PEMAHAMAN

Lingkari satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban ada di bagian akhir buku.

1. Pendampingan ODHIV baru yang khas CBC dan tidak tersedia di tempat lain sebaiknya diklasifikasikan…

a. Pertahankan
b. Integrasikan
c. Efisienkan
d. Hentikan

2. Klinik berizin klinik utama ingin memperoleh kapitasi JKN. Jalur yang paling sesuai adalah…

a. Jalur 1
b. Jalur 4
c. Jalur 6
d. Jalur 2

3. Yang dimaksud "jam anggaran daerah" dalam rencana transisi adalah…

a. Jam buka kantor Dinkes
b. Jadwal audit tahunan
c. Usulan harus masuk perencanaan daerah sekitar satu tahun sebelum anggaran berjalan
d. Batas waktu pelaporan SIHA

4. Rencana transisi sebaiknya disetujui oleh…
   a. Donor saja
   b. Badan pengawas dan dibahas bersama perwakilan komunitas
   c. Bagian keuangan saja
   d. Dinas Kesehatan saja

5. Arah "hentikan" paling tepat untuk…
   a. Kegiatan yang tumpang tindih dengan program puskesmas dan dampaknya kecil
   b. Layanan ARV
   c. Pendampingan sebaya
   d. Pelaporan SIHA

SETELAH PELATIHAN

Rencana Tindak Lanjut Saya

Tuliskan kegiatan yang akan Anda lakukan dalam tiga bulan setelah pelatihan. Fasilitator akan menanyakan kemajuannya melalui e-learning.

Kegiatan	Tujuan	Waktu	Penanggung jawab	Dukungan yang dibutuhkan	Indikator berhasil

Nama dan klinik		Tanggal	

E-LEARNING Unit 8 · Laporkan kemajuan tindak lanjut pada bulan ke-1, ke-2, dan ke-3

Kunci Jawaban Uji Pemahaman

Penjelasan setiap jawaban tersedia di e-learning setelah Anda mengerjakan kuis.

Pelajaran	Mata pelatihan	1	2	3	4	5
1	MPD 1	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**
2	MPD 2	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**
3	MPI 1	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**
4	MPI 2	**a**	**d**	**c**	**b**	**a**
5	MPI 3	**b**	**a**	**d**	**c**	**b**
6	MPI 4	**c**	**b**	**a**	**d**	**c**
7	MPI 5	**d**	**c**	**b**	**a**	**d**
8	MPI 6	**a**	**d**	**c**	**b**	**a**

Daftar Istilah

Istilah	Pengertian
Biaya penuh	Biaya tunai ditambah nilai in-kind.
Biaya tetap	Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah kunjungan naik atau turun dalam rentang tertentu.
Biaya tunai	Biaya yang benar-benar dibayar klinik atau donornya.
Biaya variabel	Biaya yang bertambah setiap ada kunjungan atau layanan.
Daya tahan kas	Saldo kas dibagi kesenjangan pendanaan bulanan; menunjukkan berapa bulan klinik dapat bertahan.
FKRTL	Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, misalnya rumah sakit dan klinik utama, yang menerima pasien JKN berdasarkan rujukan.
FKTP	Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan nonspesialistik bagi peserta JKN.
Guardrail akses	Batas yang tidak boleh dilanggar oleh keputusan pembiayaan agar akses kelompok rentan tetap terjaga (lihat Bab 8).
Kapitasi	Pembayaran bulanan dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memperhitungkan jumlah layanan yang diberikan.
Kapitasi berbasis kinerja	Penyesuaian pembayaran kapitasi berdasarkan capaian indikator kinerja FKTP.
Kebutuhan dana minimum	Biaya untuk fungsi berarah "pertahankan" dan "integrasikan" selama masa peralihan; batas bawah yang harus diamankan.
Kesenjangan pendanaan	Selisih antara biaya tunai dan pendapatan yang tetap ada setelah dukungan donor berakhir.
Kontrak sosial	Mekanisme pemerintah membiayai organisasi masyarakat untuk memberikan layanan, misalnya melalui swakelola tipe III.
Kredensialing	Proses penilaian kelayakan fasilitas kesehatan oleh BPJS Kesehatan sebelum perjanjian kerja sama.
Populasi kunci	Kelompok dengan risiko tinggi terhadap HIV, antara lain lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), waria atau transpuan, pekerja seks, dan pengguna napza suntik.
Rencana transisi	Rencana bertahap untuk mengalihkan pembiayaan dan pengelolaan fungsi klinik dari dukungan donor ke sumber domestik tanpa menurunkan akses.
Swakelola tipe III	Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan berdasarkan kontrak dengan pejabat pembuat komitmen.
Titik impas	Volume layanan atau jumlah peserta yang membuat pendapatan sama dengan biaya.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Yayasan Spiritia. Pedoman model CBC berkelanjutan: strategi keberlanjutan operasional dan finansial bagi Community-Based Clinic (CBC). Draf versi 0.5. Jakarta; 2026.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berani tes, berani lindungi diri: Kemenkes targetkan eliminasi HIV dan IMS tahun 2030 [Internet]. Jakarta: Kemenkes; 2025 Jun 21 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://kemkes.go.id/id/berani-tes-berani-lindungi-diri-kemenkes-targetkan-eliminasi-hiv-dan-ims-tahun-2030
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831. Jakarta: Kemenkes; 2022.
4. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara; 2025.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Jakarta: Kemenkes; 2025.
6. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Jakarta: Sekretariat Negara; 2018, 2024.
7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400. Jakarta: Kemenkes; 2013.
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes; 2023.
9. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara; 2025.
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Jakarta: LKPP; 2021.
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Jakarta: Kemenkes; 2024.
12. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Jakarta: Sekretariat Negara; 2022.
13. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes; 2022.
14. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Transition timelines, April 2026. Geneva: Global Fund; 2026 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://resources.theglobalfund.org/media/hvkncr4j/cr_gc8-transition-timelines_list_en.pdf
15. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Sustainable transition: advancing a managed path to domestic financing in Indonesia [Internet]. Geneva: Global Fund; 2026 Sep 16 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.theglobalfund.org/en/stories/2026/2026-09-16-sustainable-transition-managed-path-domestic-financing-indonesia/
16. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Global AIDS Strategy 2026–2031: united towards ending AIDS. UNAIDS/PCB(57)/25. Geneva: UNAIDS; 2025 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-11/PCB57_Global_AIDS_Strategy_2026-2031_0.pdf
17. Yayasan Spiritia. Self-assessment kapasitas klinik CBC: 23 responden dari 7 klinik. Oktober 2026 (data tidak dipublikasikan).

18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes; 2015.
19. Detik Health. Penjelasan BPJS Kesehatan soal pindah faskes harus menunggu 3 bulan [Internet]. Jakarta: Detik; 2026 Agu 2 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8600280/penjelasan-bpjs-kesehatan-soal-pindah-faskes-harus-menunggu-3-bulan